

Accident vasculaire cérébral

Face à une urgence ou une détresse vitale, ou en cas d'aggravation

- appliquer la conduite à tenir adaptée et réaliser en priorité les gestes d'urgence qui s'imposent ;

La victime est consciente et présente des signes d'AVC ou d'AIT

- appliquer la conduite à tenir devant une victime qui présente un malaise ;
- adapter le conduite à tenir avec :
 - installer la victime :
 - en position strictement horizontale à plat ;
 - ou en position latérale de sécurité¹ si elle présente des nausées et des vomissements ;
 - lors du 4^{ème} regard :
 - réaliser une mesure de la glycémie capillaire ;
 - rechercher les éléments spécifiques de l'AVC, les signes, les facteurs de risque et antécédents particuliers ou nécessaires à la prise en charge.
 - transmettre le bilan pour obtenir un avis médical² et respecter les consignes ;
 - poursuivre le bilan et surveiller attentivement :
 - l'évolution des signes d'AVC,
 - la conscience,
 - la respiration.

Transport

- maintenir la victime dans la position initiale pendant son transport.

Les victimes d'AVC sont idéalement acheminées vers un centre spécialisé « Unité de soins intensifs neurologiques » ou « unité neuro-vasculaire ». La prise en charge précoce des victimes d'AVC permet d'obtenir des bénéfices réels par rapport à une prise en charge conventionnelle avec un risque de mortalité et de séquelles réduit.

¹ Près des 2/3 des victimes qui présentent un AVC présentent des troubles de la déglutition associés.

² Le médecin régulateur peut vous demander de rechercher d'autres signes spécifiques ou vous mettre en relation avec un neurologue pour récolter les éléments nécessaires à une hospitalisation en unité neuro-vasculaire.